



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نعيمه احمد حسن عبده
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : ابوالنمرس
رقم البطاقة : 28112212102324 رقم التليفون : 01142072922
العنوان : -
العمر (تاريخ الميلاد) : 21-12-1981 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض
بالصبغة [11127]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. ----- /د. ----- /د. ----- /د. -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نعيمه احمد حسن عبده National ID: 28112212102324	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT Chest & abdomen and pelvis
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



 جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية

نسبه
 احمد حسن صيده
 قرية ترسا
 مركز ابو النمرس - البحيرة

٢٨١١٣٢١٢١٠٢٣٢٤

KY2970972



 ٢٠٢٥/٠١
 ٢٨١٢٢١٢١٠٢٣٢٤
 ربة منزل
 انتى
 سيد عبد الحفيظ عبد المنعم عبد الحفيظ
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/٠١/٠٥





مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

البنية التحتية
طبعة

02/21/2026

MDT FORM

Name:	Naima Ahmed Hassan Abdo	MRN:	8339
Age:	44 Y	ID:	28112212102324
Menopausal Sta:	Irregular	Phone:	01142072922
NRS SCORE:		Marital Status:	M
BMI:	27	Family History:	-ve
CO Morbidity:	free	Reason Of MDT:	post op (Lt MRM)

Clinical Data:

BX:	IDC						
ER:	8/8	PR:	6/8	HER2:	+1	KI67:	40%

R

L

Sonomammography:

post Lt MRM

Mets Workup:**History:**

Pt recieved NACT AC + Taxotere then went for LT MRM with partial response to therapy (LABCI) (1/16 LN)
ypT1c ypN1a

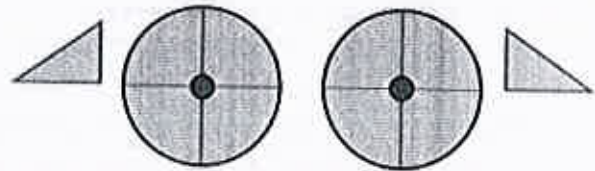
Recommendations:

consider adj. ttt.

تذكر السخري

MDT Outcome & Plan

for adj femara zoladex 7 yrs
zometa every 6 ms

**T N M****SIGNATURE**

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Women's Health Outreach Program

Name: Naema Ahmed Hassan

Date: 1-1-2025

Bilateral full field Digital Mammography

Clinical summary: 42 years old, left breast lump.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views & High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibro glandular densities, (ACR B)
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Enlarged indeterminate axillary LN reaching 16mm in long axis with focal cortical thickening reaching 4mm for follow up

Left breast

- Scattered fibro glandular densities, (ACR B)
- UOQ posterior third dense irregular mass with parenchymal distortion, no suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated a corresponding ill-defined irregular hypoechoic solid mass with spiculated margin and internal vascularity seen at 2:00-3:00 outer zone measured about 6.3x3.7cm about 0.4cm from the skin and 7.5cm from the nipple. Other nearby surrounding small ill-defined hypoechoic nodules reaching 1.1cm in diameter are noted
- Retracted nipple with retroareolar prominent ducts showing clear pattern
- Normal skin thickness and contour.
- Enlarged two pathological axillary lymph nodes with lost hilum seen at level I, largest measured 3.6x1.8cm

Impression:

Right breast (BIRADS 1): Normal study.

Left breast (BI-RADS 5): UOQ palpable malignant looking solid mass with ipsilateral pathological lymphadenopathy for biopsy

**Best regards,
Dr. Eman Ali**



Patient Name: Naeema Ahmed Hassan	Date : 17/03/2025
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 441/2025	Pat. ID: 98465

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

- Reported case of left breast cancer.

I Chest:

- Left breast heterogenous parenchyma with left axillary enlarged lymph nodes level I and II , the largest measures about 5x 3 cm seen in level I .
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of ground glass attenuation, consolidation or cavitary lesions.
- No CT evidence of pathological mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection, pleural thickening or masses.
- No cardiac gross enlargement.
- Sliding hiatus hernia is seen.

II Abdomen & pelyis:

- The liver is enlarged showing homogenous parenchymal attenauion. No sizable focal lesions on non-contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary rad'cles dilatation.
- Normal non contrast CT appearance of the spleen, pancreas, kidneys and suprarenals glands.
- Averagely filled urinary bladder showing no sizable diverticular outpouching.
- No pathological abdominal or pelvic lymph node enlargement.
- No ascites.IUCD is seen.
- Multiple variable sized dorsolumbar vertebral bodies lytic lesions are seen, the largest seen at D3 about 1.4 cm

Opinion:

- Reported case of left breast cancer revealed:
- Multiple osseous lesions as described , likely metastatic.
- No sizable pulmonary or hepatic deposits on non-contrast basis.

Prof. Menna Talla Hanafy, M.D.



Patient Name: Naeema Ahmed Hassan	Date : 17/03/2025
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 441/2025	Pat. ID: 98465

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Average in size (15cm at Rt MCL) homogenous parenchymal echopattern with smooth surface.
- No hepatic focal lesions or intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is patent and not dilated.

Gall Bladder: -

- Average distention and capacity with no stones or mud
- The wall is not thickened.
- CBD is not dilated.

Spleen: -

- Average size, homogenous.

Kidneys: -

- Both are average in size, shape and echogenicity
- No stones or dilated pelvicalyceal system
- No gross lesion

Para-aortic and pancreatic area: show no gross abnormalities.

No ascites

Urinary Bladder: -

- Average capacity with no stones or diverticular out pouching

Uterus and adnexal ; no abnormalities could be detected, IUCD is in place

Opinion:

Unremarkable study

Signature Dr . Nermien Ramadan

17/03/2025 11:33 AM

ECHO REPORT

Name: زید احمد

Date: 10 / 6 / 2025

EF	<u>69%</u>	55-75%	PWT	<u>0.7</u>	0.6-1.1cm
LVEDD	<u>4.5</u>	3.5-5.8cm	AO.R	<u>2.3</u>	2-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	<u>3.2</u>	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	<u>0.9</u>	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions normal

LV wall thickness normal

LV diastolic function DD grade I

SWMA normal

LA and Ao root dimensions normal

Mitral Valve normal

Aortic valve normal

Tricuspid valve Trivial TR

Pulmonary valve normal

Right side and systolic function normal

Intracardiac masses and effusion normal

Dr /

Dr. [Signature]



Patient Name	: الأستاذة / نعيمه احمد حسن عبده	Request No.	: 13002532
Patient No.	: 28112212102324	Request Date	: 09/01/2025
Path No.	: 109/25	Verification Date	: 30/01/2025
Sex	: Female	Financial Category	: نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- PR: Positive (score 6/8).
- Her2: Positive (score +1).
- Ki67: Positive in 40% of tumor cells.

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Dr.Rana Fathy
Dr.Nermin Mohamed

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Printing Date : 05/02/2025 17:11:13

Page 2 of 3

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt